

伤寒论条文解读

条文卡片合集 PDF

条文数量

10 条

资料定位

中医条文学习资料

本次包含

1-10条

说明：本资料内容为学习胡希恕和李冠杰老师体系心得，如有表述欠妥处，与李冠杰老师无关，是作者学习和领会不足所致。更全面的体系知识推荐大家学习胡希恕老师和李冠杰老师的《康平本伤寒论讲稿》和《金匱要略讲稿》。**声明：**以下内容仅是学习资料整理，不构成任何医学建议。

条文目录

点击任意条文，可直接跳转到对应卡片 · 目录 1/1

第1条	太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。	点击跳转
第2条	太阳病，发热汗出恶风，脉缓者，名为中风。	点击跳转
第3条	太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤...	点击跳转
第4条	伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传...	点击跳转
第5条	伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。	点击跳转
第6条	太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。若发汗已，身灼热者，名风温。风温...	点击跳转
第7条	病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳者，七日愈；发...	点击跳转
第8条	太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行尽其经故也；若欲作再经者，针足阳明...	点击跳转
第9条	太阳病，欲解时，从巳至未上。	点击跳转
第10条	风家表解，而不了了者，十二日愈。	点击跳转



第1条

1 太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

词语解析

- **太阳病**：不是某一个固定病名，而是凡见**脉浮、头项强痛、恶寒**这一组表证反应，都可归入太阳病范围。
- **脉浮**：潜在动脉高度**充血**，血中**水分增多**
- **头项强痛**：太阳病时人体为了从体表排邪，大量体液和血液趋向体表，形成浅表充血，而且**越往上部越明显**
- **恶寒**：体表温度升高，**空气温差骤然变大**，会感觉外面空气很冷

要点总结

第1条是**太阳病总纲**。

核心证候：脉浮、头项强痛、恶寒。

病理抓手：病在表，正气趋表，欲汗不得汗。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲太阳病，重点不把它看成某个固定病名，而看成**人体在表的一种抗病反应**。外邪来时，机体先把**抗病力量调到体表**，**血液、水分也趋向体表**，所以见脉浮。

头项强痛，**上半身、头项部充血较重**；恶寒，体表温度升高，与外界**温差增大**。胡老也常提醒，太阳病只是总纲，具体治疗还要继续分中风、伤寒、温病，以及有汗无汗、发热轻重、脉缓脉紧等，不可见太阳病三字就固定用一个方。

李冠杰讲解

李冠杰老师把第1条视为**太阳病总纲**，它**不是讲现代医学某一个病**，而是给后面所有太阳病条文定范围。

这一条最重要的三个抓手是**脉浮、头项强痛、恶寒**。

学习时要把第1条和第2、第3条连起来看：第1条定太阳病范围，第2条分出中风，第3条分出伤寒，后面桂枝汤、麻黄汤等方证都从这里展开。



第2条

① 太阳病，**发热汗出恶风，脉缓者**，名为**中风**。

词语解析

- **中风**：这里的中风不是卒中，而是太阳病中的一类表虚证，核心是**发热、汗出、恶风、脉缓**。
- **汗出**：**不是大汗出，而是潮乎乎的汗**，出了汗，但达不到驱逐疾病的效果
- **恶风**：汗后体表疏松、湿润，风一吹，散热加快，因此格外怕风
- **脉缓**：缓和紧相对（用烟卷类比，**烟多则紧，烟少则缓**），脉缓的原因是，汗出了**水分丧失了一部分**

要点总结

第2条提出太阳中风。

辨证核心：**发热、汗出、恶风、脉缓**。

与伤寒区别：**中风偏表虚有汗，伤寒偏表实无汗**。

恶寒：没有风吹也怕冷；恶风：风吹怕冷加重

胡希恕讲解

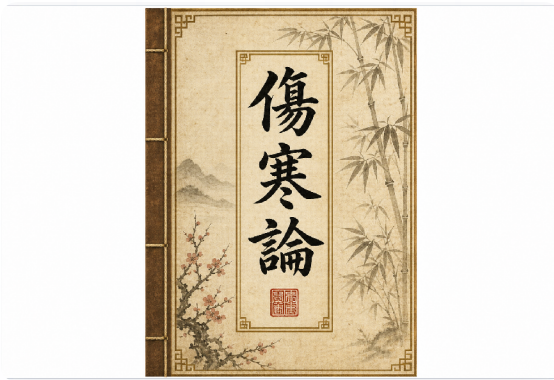
胡希恕老师讲中风，不是现代所谓脑卒中，而是太阳病里**表虚有汗**的一类。发热和汗出并见，说明人体已经有向外排邪的趋势，但卫外不固，汗出而表仍不解；

这一条为后面的桂枝汤证作铺垫。胡老辨桂枝汤，不是单看发热，而是看**汗出、恶风、脉缓弱、表虚营卫不和**这一组反应。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲这里的“中风”不能望文生义成脑血管病，而要回到条文本身。本条重点是**发热、汗出、恶风、脉缓**。它和第3条伤寒正好相对：中风有汗、脉缓，伤寒多无汗、体痛、脉紧。

本条就是太阳中风的主干，后面第12、13条桂枝汤证是对它的展开。



第3条

1 太阳病，或已发热，或未发热，**必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤寒。**

词语解析

- **伤寒**：指表实证。核心是**恶寒重、体痛、呕逆、脉紧**。
- **或已发热，或未发热**：发热可已出现，也可暂未出现，但**恶寒**是太阳伤寒的**标志症状**。
- **体痛**：大量体液、血液被输送到体表，微细血管**高度充盈**，压迫身体组织和神经，于是出现体痛。
- **呕逆**：全身毛孔闭塞后，气不得向外疏散，便循**消化道上逆**，形成想吐、呕逆
- **脉阴阳俱紧**：体液、血液把血管充得**饱满**，按下去就显得紧而有力

要点总结

第3条提出太阳伤寒。

发热可有可无，但恶寒是必见的

核心抓手：必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧。

与第2条区别：第2条偏汗出脉缓，第3条偏无汗脉紧。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲太阳伤寒，核心是表实无汗、寒束于表。**发热可有可无，但恶寒是必见的**，因为表闭未开，正邪相争在表。

体痛说明表闭较重，经脉、肌肉气血不利；呕逆是表证较重时影响胃气上逆；脉阴阳俱紧，则是寒邪束表、津液不得外达的脉象。

胡老会把本条和第2条对读：第2条是桂枝汤方向，第3条是麻黄汤方向。临床不能只看“太阳病”，还要看**有汗无汗、脉缓脉紧、身痛轻重**。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲原文用“或已发热，或未发热”提醒我们，**发热不是最硬的判断点**。真正必须抓住的是**必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧**。尤其“必恶寒”说明只要表证未解，**恶寒就很关键**。

“伤寒”只是这组症状反应的名称，**不是说患者一定受到外界寒邪侵袭**，也不是某条经络发生病变。

第3条界定的是太阳伤寒证型，还不能直接与麻黄汤方证完全画等号；具体使用麻黄汤，还要继续结合第35条的无汗、身疼腰痛、骨节疼痛、喘等完整方证。病人不会完全按照书本上的固定症状组合发病，仍须综合判断。



第4条

3 伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。

词语解析

- 一日太阳受之：传与不传，唯一标准是**症状反应**
- 脉若静：脉不特别大、不特别快，病势相对平静，提示**病轻，暂不向内发展**。
- 颇欲吐：不是微微恶心，而是**很想吐**，提示有向少阳柴胡证方向发展的趋势。
- 躁烦、脉数急：烦躁、脉快而急，说明病势在进展，要警惕**传变风险**。

要点总结

第4条讨论伤寒初起的传与不传，唯一标准是**症状反应**。

不传抓手：**脉若静**。

欲传抓手：**颇欲吐、躁烦、脉数急**。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲传与不传，不主张死按一日太阳、二日阳明、三日少阳这样的机械传经。关键仍是**观察脉证变化**。

脉若静，说明病势平稳，暂时没有向内发展的证据；如果出现颇欲吐、躁烦、脉数急，说明病势活动起来，可能转向少阳、阳明或其它阶段。

胡老的思路是：**不要用日期决定治疗，而要看当前有没有新的方证**。传不传，不在日数，而在欲吐、躁烦、脉数急等**实际证候**。

李冠杰讲解

李冠杰老师指出不是太阳病主纲，而是对伤寒初起病势变化的说明。

本条最有用的是把“静”和“动”分开看：**脉若静者，为不传**，是病势暂平；**颇欲吐、躁烦、脉数急**，是向内或向其它证转化的苗头。

学习时不要把“伤寒一日，太阳受之”读成固定流程。李冠杰更强调：这是给临床观察病势的一个方法，**仍然要以证候为准**。



第5条

3 伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。

词语解析

- 二三日：只是观察病势变化的时间窗口，不可按日数机械判定传经。
- 阳明证不见：未见里热、口渴汗出、胃家实、腹满便硬等阳明方向证据。
- 少阳证不见：未见往来寒热、胸胁苦满、心烦喜呕、口苦咽干等少阳方向证据。
- 为不传：没有新证据就不能预设传变，仍应按现有脉证辨治。

要点总结

- 第5条承接第4条，继续判断传与不传。
- 核心标准：阳明、少阳证不见者，为不传也。
- 临床原则：按现有脉证辨治，不按日数预设传变。

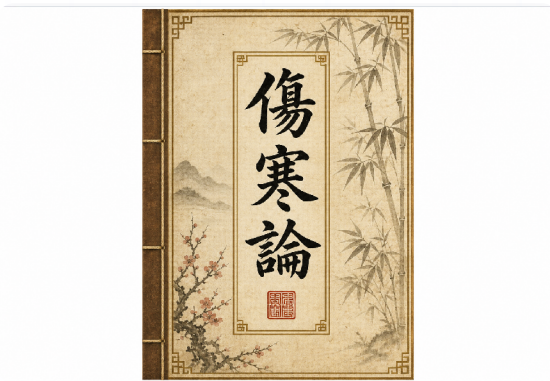
胡希恕讲解

胡希恕老师讲第5条，仍是反对机械传经。二三日只是病程中的观察点，不能说到了二三日就一定传阳明、少阳。
真正要看的，是有没有阳明里热、胃家实、少阳半表半里这些具体表现。若阳明、少阳证不见，就说明病势没有向这些方向发展。
所以本条的临床精神是：不要用日期决定治疗，要用当前证候决定治疗。传不传，不在日数，而在证据。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第5条为降两字格，标三级。它承接第4条，继续说明传与不传不是按日期硬算。
“阳明、少阳证不见”是本条主眼：没有口渴汗出、胃家实、往来寒热、胸胁苦满、喜呕等证据，就不能说已经传入阳明或少阳。
学习时要抓住一句话：见证才算，不见证不算。这是防止套六经流程的关键。

第6条



- 1

太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。
- 2

若发汗已，身灼热者，名风温。
- 1

风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。
- 2

若被下者，小便不利，直视失溲；若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘈瘲；若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。

词语解析

- 温病：温病不属于太阳病，与太阳病的明显区别：“不恶寒，渴”
- 发热而渴：渴是内热的表现，像阳明病白虎汤证也是
- 风温：温病误汗后热势更盛，见身灼热、自汗出，说明汗法伤津助热。
- 自汗出、身重、多眠睡：热盛津伤、正气受困，出现身重嗜睡、鼻鼾、语言难出等重象。
- 误下误火：温热病误下、误火，可见小便不利、直视失溲、发黄、惊痫、瘈瘲，为危重变证。
- 不恶寒：里热太甚，大过温差带来的恶寒感，所以不怕冷

要点总结

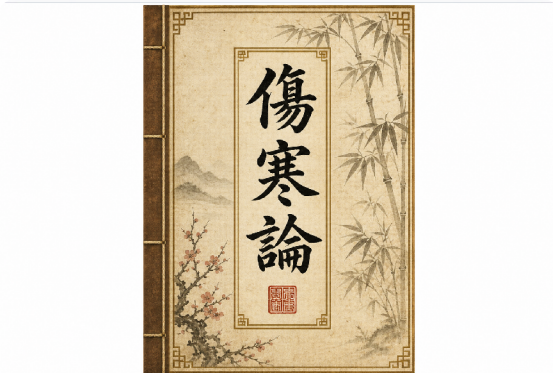
- 第6条要分段看：温病、风温、风温为病、误治变证。
- 温病抓手：发热而渴，不恶寒。
- 治疗边界：不可按太阳伤寒、中风随便发汗。
- 误治风险：汗、下、火法皆可促成危候。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第6条，重点是把温病、风温同普通太阳中风、伤寒分开。它虽然写“太阳病”，但抓手是发热而渴，不恶寒，说明病性偏温热，津液已受影响。若误发汗，热势更盛，出现身灼热、自汗出、身重、多眠睡、鼻鼾、语言难出，这已不是一般表证。后半反复讲误下、误火、火熏的危害，是提醒医者：温热病不可误用汗、下、火法，必须先辨病性，再定治法。

李冠杰讲解

李冠杰老师特别注意第6条的康平本排版：本条内部有顶格、降一字格，卡片中应分段看等级，而不是把长条文一概当成同一层。第一段以发热而渴，不恶寒定温病主眼；第二段讲误汗后身灼热为风温；第三段列风温重证；第四段讲误治危候。学习本条最重要的是：温病不是太阳伤寒、中风，误汗误下误火都可能加重。



第7条

3 病有**发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也**。发于阳者，七日愈；发于阴者，六日愈；以阳数七、阴数六故也。

词语解析

- **发热恶寒**：发热与恶寒并见，说明正气抗邪较有力，多从**阳性表证**方向理解。
- **无热恶寒**：只恶寒而不发热，提示机能沉衰、阳气不足，要警惕**阴证、少阴或里虚寒**。
- **发于阳、发于阴**：不是固定病名，而是根据**发热有无和整体机能状态**判断阴阳属性。
- **七日、六日愈**：属于古人病程与术数解释，临床可参考，**不能代替辨证**。

要点总结

- 第7条区分**发于阳、发于阴**。
- 阳性抓手：**发热恶寒**。
- 阴性抓手：**无热恶寒**。
- 六七日只是病程参考，**不能替代脉证辨证**。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第7条，会把重点放在阴阳属性上。**发热恶寒**，说明人体抗病机能较亢奋，多属阳性病；**无热恶寒**，则阳气不足、机能沉衰的意味更重。
“七日愈、六日愈”只是古人对病程的概括，不能当成绝对日程。
本条实用点是：**不要只看恶寒两个字就判太阳病**，还要看有没有发热、脉象强弱、精神饮食等整体虚实。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第7条为**降两字格**，标三级。它不是太阳病主纲，而是说明发病阴阳属性与病程倾向。
“发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也”是本条核心。发热代表正气抗邪仍有力量，无热而恶寒则提示机能不足。
阳数七、阴数六可作传统解释了解，临床仍要抓**发热与否、恶寒性质、整体虚实**。



第8条

3 太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行尽其经故也；若欲作再经者，针足阳明使经不传则愈。

词语解析

- **头痛至七日以上自愈**：说明有些太阳病随着正气恢复可以自解，**不是所有太阳病都必然传变**。
- **行尽其经**：按经脉运行解释病程，学习时可懂其意，**不可机械套时间**。
- **欲作再经**：病势似有继续转向的苗头，要观察是否出现**新的阳明、少阳或其它证候**。
- **针足阳明**：古人截断传经的一种思路，临床核心仍是**当前脉证是否转变**。

要点总结

第8条讨论太阳病**自愈与再传**。

再传判断：看是否出现**新的证候方向**。

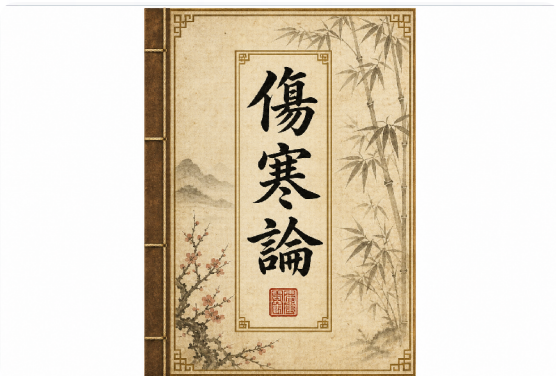
临床重点仍是**看脉证，不按日数硬套**。

胡希恕讲解

胡希恕老师不会把第8条理解成太阳病一定七日传完。**头痛至七日以上自愈**，说明部分太阳病可随着正气恢复而自行解除。
“欲作再经”只是提示病势可能继续变化，要看有没有新的证候出现。
本条的临床意义是：轻证可观察，变化则随证处理；所谓针足阳明，也不能离开**当前脉证**。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第8条为**降两字格**，标三级，延续前面关于传经、病程的讨论。
“头痛至七日以上自愈”说明太阳病并非一定越来越重；“欲作再经”才提示要注意下一步变化。
学习时要防止把传经当固定程序，真正有用的是**观察病势，看证候是否转向**。



第9条

3 太阳病，欲解时，从巳至未上。

词语解析

- **欲解时**：指病势将要解除、症状有缓解趋势的时间段，不是固定处方依据。
- **巳至未上**：约上午九点到下午三点，阳气较盛，古人观察到太阳病较易**趋于缓解**。
- **如何判断欲解**：应看**恶寒减、脉转和、汗出得当、精神转佳**等实际变化。
- **临床看法**：时辰只作辅助参考，真正依据仍是**证候是否转解**。

要点总结

第9条讲太阳病欲解时。

判断欲解要看恶寒减、脉转和、精神转佳。

不可拘泥时辰，仍以实际脉证为准。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲“欲解时”，多作病势观察参考，不把它当成决定治疗的核心。太阳病欲解从巳至未，是说阳气较盛时病势容易缓解。

但病是否真要解，仍要看**恶寒是否减轻、脉是否和缓、汗出是否得当、全身状态是否转佳**。

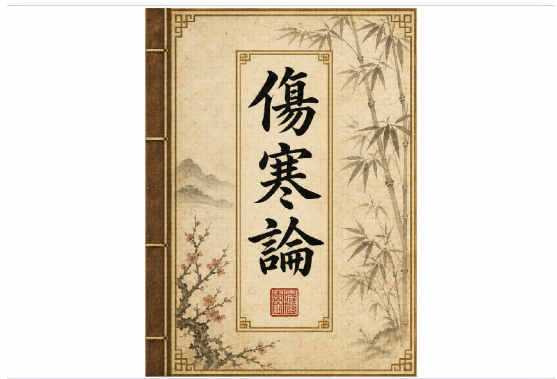
所以本条能帮助观察病程，却不能代替方证辨证。可靠的是**证候转和、病人自觉改善**。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第9条为**降两字格**，标三级。它是太阳病欲解时间的说明，不是主干方证条文。

“从巳至未上”大致是上午到下午阳气旺的时间段，古人借此说明太阳病有趋解的时机。

学习时可记其意，不必拘其时；要放在病势观察中用，**时辰只是辅助，脉证才是依据**。



第10条

3 风家表解，而不了了者，十二日愈。

词语解析

- **风家**：表虚经常容易感冒体质。
- **表解**：表证已经解除，恶寒发热等表证主矛盾不在，**不宜再强行解表**。
- **不了了**：表解后仍有轻微不爽、不清利、余证未尽，并非大病未解。
- **十二日愈**：提示恢复需要过程，轻微余证可待其自复，避免**过度发汗**、**过度攻伐**。

要点总结

第10条讲太阳中风表解后的恢复。

处理原则：余证轻微可观察，避免过治。

尤其要防止表已解而反复发汗。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲“风家”，常联系太阳中风、表虚有汗一类。表解以后还有“不了了”，多是余邪未尽或正气未复，不一定需要再大发汗。

“十二日愈”提示病后恢复有过程。若表证已解，只剩轻微不爽，就要避免过度治疗，尤其不能把余证当成表邪未解而反复发汗。

本条精神是：**表解后看余证轻重，轻者可待其自复**。治疗不是越多越好，关键是不 要扰乱恢复。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第10条为**降两字格**，标三级，讲的是风家表解后的余证恢复。

“不了了”不是大病未解，而是表证已去、身体还没完全清爽。若误以为还要继续强发汗，反而可能伤津伤正。

学习本条要抓住：**表解以后，不要见一点不爽就继续攻表**。观察恢复过程，也是辨证的一部分。